全スタッフ（看護師・薬剤師・リハビリ・事務・介護職）

# 認知バイアスと日常の判断 ― なぜ優秀な人でも間違えるのか

全スタッフ向け勉強会スライド（20分）

参考文献



2026-03-30 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

# なぜ優秀な人でも判断を間違えるのか

> *「ICUの剖検研究（Podbregar 2001）では、医師が"完全に確信がある"と評価した診断でも、**約4割で剖検の所見が食い違っていました**（治療を変えうる見逃しは約9%）。確信の強さは正しさを保証しません。これは能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題です」*

- 航空業界の教訓: パイロットの「ミス」を「ヒューマンファクター」として再定義
  - 結果: 航空の安全性向上に寄与したとされる
- 医療でも同じアプローチが使える
- 今日のテーマ: **「注意しましょう」ではなく「仕組みで防ごう」**

# 学習目標

この勉強会の後、あなたは以下ができるようになります:

1. **説明できる**: 認知バイアスが「個人のミス」ではなく「脳の仕組み」であることを説明できる
2. **実践できる**: 日常業務で1つ、バイアスを防ぐ具体的な方法を実践できる
3. **評価できる**: チームでの安全確認の仕組みが機能しているか振り返れる

# 速い脳と遅い脳

私たちの脳には2つのモードがあります:

| | 速い脳（System 1） | 遅い脳（System 2） |
|---|---|---|
| スピード | 一瞬で判断 | じっくり考える |
| エネルギー | 省エネ | エネルギー大量消費 |
| 得意なこと | パターン認識、直感 | 論理的思考、計算 |
| 日常の例 | 「あ、この人怒ってる」と表情で察する | 「78×34は…」と計算する |
| 仕事の例 | 「いつもと様子が違う」と感じる | 薬の量をダブルチェックする |

- **速い脳は優秀** — 仕事の大半はこれで回っている
- **でも時々間違える** — それが「認知バイアス」
- **大事なポイント**：バイアスは**誰にでも起きる**。頭が良い・悪いの問題ではない

# 日常業務で起きるバイアス 4つ

## 1. 確認バイアス —「思い込みメガネ」

- **意味**: 一度「こうだ」と思うと、それを裏付ける情報ばかり目に入る
- **仕事での例**:「この患者さんはいつも大げさ」→ 本当の痛みを聞き逃す
- **日常の例**:「あの店はまずい」→ 美味しい料理も気づかない

## 2. アンカリング —「最初の情報に引きずられる」

- **意味**: 最初に聞いた情報が基準になって、そこから離れられない
- **仕事での例**: 申し送りで「発熱なし」→ その後37.8℃出ても「大したことない」と判断
- **日常の例**: セール「50%OFF」→ 元値が高くても「お得」と感じる

# 日常業務で起きるバイアス 4つ（続き）

### 3. 利用可能性バイアス —「最近の記憶に引っぱられる」

- **意味**: 最近経験したこと・印象的なことが「よくあること」に感じる
- **仕事での例**: 先週転倒事故があった → 今週は転倒ばかり気にして、他のリスクを見落とす
- **日常の例**: 飛行機事故のニュースを見た直後 → 飛行機が怖くなる（実際は車の方が危険）

### 4. 過信 —「わかったつもり」

- **意味**: 自分の判断を実際以上に正しいと思ってしまう
- **仕事での例**:「この薬は何度も扱ったから大丈夫」→ 確認を省略してインシデント
- **ベテランほど注意**: 経験が増えると「速い脳」で処理する割合が増え、確認を省きやすくなる

まとめ

# 4つのバイアスまとめ

| バイアス | ひとことで言うと | 仕事で起きやすい場面 |
| --- | --- | --- |
| 確認バイアス | 思い込みメガネ | 申し送りの先入観、「いつもの」患者さん |
| アンカリング | 最初に引きずられる | 前の勤務帯からの情報、紹介状の診断名 |
| 利用可能性 | 最近に引っぱられる | インシデント直後の過剰反応、流行疾患 |
| 過信 | わかったつもり | ルーティン業務の確認省略、ダブルチェック省略 |

**共通点**：どれも**速い脳の「省エネモード」**が原因

**対策の基本**：意識的に**遅い脳のスイッチを入れる**タイミングを作る

# チームでバイアスを防ぐ ― 5つの問い

カンファレンスや申し送りで使える**「バイアスチェック 5つの問い」**:

1. **「他に何かない？」** → 確認バイアス対策
   - 最初の判断以外の可能性を1つ考える
2. **「最初の印象に引きずられてない？」** → アンカリング対策
   - 前の情報をいったんリセットして見直す
3. **「最近の経験に影響されてない？」** → 利用可能性対策
   - 先週の出来事と今回の状況は別物
4. **「どれくらい確信がある？根拠は？」** → 過信対策
   - 「なんとなく大丈夫」を言語化する
5. **「もし間違っていたら、一番ありそうな理由は？」** → 総合チェック
   - 最悪のケースを先に想像する（プレモーテム）

# ダブルチェックの本当の意味

> *「ダブルチェックは"2回確認すること"ではありません。"別の視点で確認すること"です」*

**形骸化しやすいパターン**：

- 同じ人が2回見る → 同じバイアスが2回働くだけ
- 「確認しました」にサインするだけ → チェックリスト疲れ

**効果的なダブルチェック**：

# ダブルチェックの本当の意味（続き）

- 別の人が独立して確認する
- 「何を確認するか」を明確にする
- 「おかしい」と思ったら声を出す文化

**Devil's Advocate（あえて反論する役割）**：

- チームの誰かが「本当にそれで合ってる？」と問う役を担う
- これは**批判ではなく安全の仕組み**

# 「自分もバイアスを持つ」= 強さ

> *「バイアスがあることは恥ずかしいことではありません。バイアスに気づける力こそが、プロフェッショナルの証です」*

- **メタ認知**：自分の考え方について考えること
- バイアスを認められる人 = メタ認知能力が高い人
- 「私、思い込みで判断してたかも」と言えるチーム = **心理的安全性の高いチーム**

**航空業界の文化転換**：

- 昔:「機長に逆らうな」→ 多くの事故
- 今:「おかしいと思ったら誰でも声を上げる」→ 安全性の向上に寄与したとされる
- **CRM（Crew Resource Management）**：チーム全体で安全を守る仕組み

# グループワーク ― うちのチームでできること

**ワーク（5分）**: 3-4人グループで

> *「あなたの職場で、認知バイアスが原因で"ヒヤリ"とした経験はありますか？*
>
> *そのとき、どんな"仕組み"があれば防げたと思いますか？」*

- 付箋に1人1つ書いて、グループ内で共有
- グループで「明日から試せそうなこと」を1つ選ぶ

**共有（3分）**: 各グループから1つずつ発表

**ファシリテーターポイント**：

- 「誰が悪い」ではなく「どんな仕組みが必要か」に焦点
- 小さなことでOK（「申し送りの最後に"他にない？"を追加する」等）

まとめ

# 明日からのアクション

**職種別アクション例**：

| 職種 | 明日からできること |
| --- | --- |
| 看護師 | 申し送りの最後に「他に気になることは？」を追加 |
| 薬剤師 | 「いつもの薬」でもラベルを読む3秒ルール |
| リハビリ | 「前回と同じメニュー」を選ぶ前に状態を再評価 |
| 事務 | 「いつもの手続き」でも変更点がないか確認 |
| 介護職 | 「いつもと違う」を感じたら、まず声に出す |

# 明日からのアクション（続き）

**持ち帰りメッセージ**：

> *「バイアスは脳の仕組み。だから"気をつける"だけでは防げない。**仕組みで防ぐ**。」*

**参考**：


- Kahneman, D. (2011). ファスト＆スロー
- Saposnik G et al. (2016). Cognitive biases associated with medical decisions: a systematic review. BMC Med Inform Decis Mak 16:138. PMID 27809908
- Podbregar M et al. (2001). Should we confirm our clinical diagnostic certainty by autopsies? Intensive Care Med 27:1750-1755. PMID 11810118